Diskussion 2043

Datum: 1935-06-04
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 4
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Ola Isacsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag skall be att i största korthet få anföra några av de skäl, som varit avgörande för reservanterna, då de icke kunnat ställa sig på utskottets linje på denna punkt.

Det är så, att den tilltänkta ändringen av hälsovårdsområdena skulle bli ett led i en förbättrad förebyggande sjukvård. Man har ansett det vara så viktigt, att man från alla håll gått in för detta förslag. När man då ser på skillnaden mellan reservanternas och utskottets ståndpunkter, tycker jag för min del, att det svär något mot det allmänna intresset och den allmänna uppfattningen om hälsovårdsnämndernas betydelse, då man ser, att utskottets ma-Joritet stannat vid en gränsdragning, som av reservanterna icke kunnat godkännas och som icke heller kunnat godkännas av Kungl. Maj:t. I den kungl. propositionen föreslås, att gränsen skulle dragas vid ett invånarantal av 1,500. I utskottets förslag vill man draga gränsen vid 3,000. Vi ha i utskottet försökt komma till enighet på denna punkt, men förgäves. Man anför från utskottsmajoritetens sida, att här är det alla skäl att gå försiktigt fram, och att man först måste pröva sig fram o. s. v., och så har man därför icke velat gå med på den kungl. propositionen. Jag har för min del den uppfattningen, att en gränsdragning vid 1,500 invånare är mera naturlig, mera Ööverensstämmande med den gräns, som nu gäller för att välja kommunalfullmäktige. Och jag har svårt att förstå, varför en annan gräns skall dragas för skyldigheten att välja hälsovårdsnämnd. Man kan icke gärna anföra som skäl, att det skulle vara mindre intresse för hälsovårdsnämnden i en kommun med 1,500 invånare än 1 en kommun på över 3,000 invånare. Är det riktigt, att bostadsvården anses vara ett så viktigt led i den förebyggande sjukvården, finns det fullgoda skäl att ålägga också kommuner med 1,500 invånare och därutöver att välja särskild nämnd. TI fortsättningen av förslaget komma vi till en sådan anordning, att den nya distriktssköterskan skulle i någon mån sysselsättas med bostadsinspektion och bostadsvård. Hälsovårdsnämnden är tänkt som ett stöd i denna **henne s²** verksamhet. Jag har svårt att tänka mig, att **hennes²** verksamhet skall få den avsedda effekten, om man vägrar att ge **henne²** det auktoritativa stöd, som **hon²** skulle ha i hälsovårdsnämnden.

Det finns bland de yttranden, som äro avgivna över förslaget, sådana, som gå så långt, att de anse, att det är så viktigt, att det skulle åläggas varje kommun, oavsett dess invånarantal, att utse hälsovårdsnämnd, men med rätt att kunna få dispens från förordningen, där någon förnuftig anledning skulle finnas.

Nu säger utskottets majoritet, att gräsen skall dragas vid 3,000 invånare, och därifrån skall icke finnas någon dispensrätt. Reservanterna föreslå 1,500 med rätt till dispens. Jag är för min del övertygad, att om utskottets förslag skulle segra, komme det att visa sig, att Kungl. Maj:ts förslag är det enda riktiga, ty de kommuner, som man icke ålägger att välja hälsovårdsnämnd, komma i stor utsträckning att inse betydelsen av detta organ och välja sådant. Med vetskap om utvecklingen på detta område redan nu anser jag därför, att det ser märkvärdigt ut att draga någon gräns, som kan störa den utveckling, som pågår. Vi ha icke blivit övertygade om, att utskottets linje är den riktiga, och då vi, som sagt, äro eniga om att hälsovårdsnämnderna komma att få stor betydelse för den förebyggande verksamheten, ha vi kunnat ansluta oss till förslaget.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, som innebär bifall till Kungl. Maj:ts förslag.

2. Gerhard Strindlund (Bondeförbundet, man)

Herr talman! Jag ber att få yrka bifall till den av mig och herr Johanson i Hallagården vid utlåtandet fogade reservationen.

3. Anders Andersson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag vill göra mig till talesman för några synpunkter i denna fråga utan att framställa något yrkande.

För det första är jag av den uppfattningen, att det varit lyckligast, om frågan om lösningen av distriktsvården hade kunnat ske i samband med anordnandet av dispensärverksamheten. Det hade då kunnat bli litet bättre grepp över det hela, om man från början fått klart för sig, hur det kunnat ordnas och organiseras. Vidare vill jag säga, att jag betvivlar, att det i vissa områden av vårt land blir möjligt att utnyttja distriktsvården i hela dess utsträckning. Men förslaget sådant det föreligger är ju icke utskrivet på ett sådant sätt, att man är tvungen att tillämpa det i dess helhet. Propositionen är, liksom utskottets utlåtande, synnerligen vagt skriven, och det är svårt för en lekman att tolka vad som verkligen skall komma fram ur de olika punkterna. Vad jag särskilt vill framhålla är, att sådant jag ser förslaget skola de landsting, som ordnat sin dispensärvård på särskilt förtjänstfullt sätt, bestraffas för att de gjort det. Om de fasthålla vid den organisation, som införts, skola de enligt det föreliggande förslaget icke ha rätt att få statsbidrag för distriktssköterskorna.

Jag vill erinra om att Hallands läns landsting ordnat sin dispensärvård på ett sätt, som väckt uppmärksamhet över hela landet, och det har studerats av sakkunniga från olika håll, för att det skall komma till tillämpning även på andra ställen. Vi ha ordnat hela dispensärvården under en läkare, som är helt avlönad av landstinget och icke har rätt att ha annat arbete än att sköta dispensärvården. Enligt det föreliggande förslaget är det föreskrivet, att för dessa distriktssköterskor och dispensärsköterskor skola vederbörande provinsialläkare eller extra provinsialläkare vara förmän. Om vi skola tillämpa detta system, bryta vi ned hela vår organisation. Ty det bör vara klart för var och en, som är inne i arbetet, att om vi skola

bibehålla den organisation vi ha, måste den läkare, som är chef för dispensärvården, också vara den som är ansvarig för dispensärsköterskorna. Nu finns kanske visserligen möjlighet att få dispens från dessa bestämmelser, fastän jag har svårt att komma till den uppfattningen. Författningen sådan den föreligger beträffande dispensärvården föreskriver nämligen, att vederbörande provinsialläkare skall vara förman. Nu förekommer i distriktsvårdsförfattningen ett medgivande, att man kan få dispens från detta. Huruvida denna författning kan upphäva bestämmelserna om dispensärvården, är för mig svårt att tolka. Det förefaller mig, som om reservanterna, företrädda av herr Strindlund m. fl., skulle ha en mot utskottets majoritet stridande åsikt i vad gäller rätt att uppbära hela eller halva statsbidraget. Det är alltså flera än jag som ha svårt att tolka bestämmelserna i dessa författningar. Under den förberedande behandlingen har Jag hänvänt mig till medicinalstyrelsen och till Nationalföreningen mot tuberkulos för att få ett sakkunnigt uttalande om hur författningen skall tolkas. Olika uppgifter ha meddelats mig, hur förevarande bestämmelse skulle komma att tillämpas beträffande Hallands läns landsting, och det har framhållits, att enda möjligheten för oss vore att få dispens från medicinalstyrelsen i fråga om författningens tillämpning. Jag vill för min del framhålla som särskilt önskvärt och uttala en vädjan till Kungl. Maj:t och särskilt till chefen för socialdepartementet, att då nu, enligt vad som framgår av propositionen, författningen om dispensärvården nästa år skall komma till tillämpning, denna författning blir så ordnad och utformad, att de landsting, som ha det så ordnat som vi i Halland, icke skola straffas för detta, utan att en sådan ordning skall införas att vi få rätt att bibehålla vår nuvarande organisation och att för dessa **sköterskor**[3] uppbära lika högt statsbidrag, trots det, att den läkare, som är chef för denna dispensärvård, fortfarande står kvar som chef för dispensärsköterskorna. Det är ett särskilt önskemål, som jag vill framställa, och som jag hoppas också skall kunna bli beaktat, så att vi kunna komma till praktiskt resultat.

Slutligen vill jag framhålla, att det sätt, varpå vi ordnat denna angelägenhet inom Hallands läns landsting, visat sig så fördelaktigt, att man under den tid det tillämpats redan kunnat få fram en mycket stark tendens till nedgång av tuberkulossjukdomen, och det är, såsom vi se det, ett av de mest talande bevisen för gagnet och nyttan av den organisation vi ha. Och den är därför värd att i fortsättningen få vara till vid sidan av den övriga sjukvården.

4. Adolf Wallerius (–, man)

Herr talman! Det är nog sällan en talare kan så ord för ord instämma med en annan talare som jag kan med herr Andersson i Falkenberg i vad han sagt om Hallands län. Jag har bara att sätta in Göteteborgs och Bohus” läns landstingsområde. Också där är en sådan dispensärvård anordnad, som jag tror har bidragit till att länet, som tidigare stod högre på skalan bland de av tuberkulos hemsökta länen, nu är nummer 8 bland Sveriges län i det avseendet. Jag vill understryka, att när utskottet framhåller, att det står öppet att ordna denna vård på det ena eller andra sättet och att det icke föreligger något tvång, motverkas det i praktiken av denna betydande skillnad i statsbidrag, och jag är därför inställd i samma riktning som herr Strindlunds och herr Johansons i Hallagården reservation, då de vilja, att man skall avvakta denna nu förestående nya ordning av dispensärverksamheten.

När jag emellertid tror, att utskottets förslag kommer att segra i det stora hela, skulle jag vilja yttra mig om ett par detaljer. När jag säger, att det är stor skillnad i statsbidrag, menar jag icke, att de föreslagna 1,000 kronorna äro för mycket för distriktssköterskorna, utan när man närmare undersöker kostnaden för dessa och tänker på vad landstingen ha för stora utgifter i övrigt, tror jag, att man kan finna skäl att understödja herr Svenssons i Kompersmåla reservation, som går ut på att statsbidraget skulle gå upp till 1,200 kronor.

Slutligen vill jag säga med avseende å bostaden, att när det talas om ett rum och kök som ett minimum, kan jag icke tänka mig, att det blir möjligt att stanna vid detta i verkligheten, ty **sk öterskan³** måste väl ha ett mottagningsrum, och man kan icke tänka sig att **hon²** i sitt sovrum skall taga emot svåra förbandsfall o. d. Därför tycker jag, att det är så gott att taga steget fullt ut. Jag ber fördenskull att få instämma i herr Holmströms och **fru²** Nordgrens reservation i det avseendet, då de påyrka att en bestämmelse om två rum och kök skall införas.